Les complications du décubitus

Cours reconstruit à partir de la banque de QCM : tout ce qu'il faut comprendre pour répondre aux questions, rien de superflu.

Comment lire ce cours
TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; le chiffre ×N indique combien de fois il apparaît dans la banque. Les étoiles donnent la priorité : ★★★ ≥ 8 questions, ★★ 4 à 7, ★ moins de 4.
✔ = proposition juste dans la banque · ✘ = proposition fausse (les pièges).

Sources : Cours Pr F. BENLEBNA (Médecine Physique et de Réadaptation, CHU Mostaganem) + Banque QCM OTR (≈ 36 QCM escarres / complications du décubitus).

Les 10 points à connaître avant tout

1 Les complications du décubitus sont définies par **toute complication due à un alitement prolongé** (médical, chirurgical ou autre). La prévention est la seule option valable.

2 L'**escarre** est la complication cutanée la plus redoutée. Classification EPUAP/NPIAP en **stades 1 à 4** selon la profondeur. Stade 1 = érythème persistant (réversible) ; stade 4 = exposition os/muscles (risque d'ostéite).

3 Zones d'appui principales en décubitus dorsal : **sacrum +++**, talons, occiput, malléoles. En position assise : ischions. La région deltoïdienne est **rarement** le siège d'escarres.

4 Facteurs favorisants : pression/cisaillement/macération (extrinsèques) + dénutrition, incontinence, âge, troubles sensitifs/moteurs (intrinsèques).

5 Prévention escarres : **changement de position toutes les 2–4 h**, support adapté (matelas à pression alternante), prévention de la macération, nutrition, mobilisations.

6 Complications cardiovasculaires **les plus précoces** (dès J4) : TVP / EP. Prévention = bas de contention + HBPM. Le déconditionnement cardio est précoce (pas tardif).

7 Complications respiratoires : stase bronchique, atélectasies, encombrement, pneumopathie de décubitus. L'immobilisation augmente stase et infection.

8 Complications locomotrices : ostéoporose d'immobilisation (hypercalciurie dès J2), amyotrophie, rétractions, **PAON** (paraostéoarthropathie neurogène = ossification ectopique), raideurs.

9 Complications neurologiques : compressions nerveuses (ulnaire, radial, sciatique, fibulaire commun). Complications urinaires : stase, infection, lithiase. Digestives : constipation, fécalome.

10 Traitement d'une escarre constituée : suppression d'appui, soins locaux (pas d'antibiotiques locaux systématiques), ATB systémique si infectée, chirurgie (lambeaux) si échec. Contact osseux au stade 4 → rechercher ostéite.

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréquence	Priorité
Stades d'escarre (1–4) et classification	≈ 10	★★★
Zones d'appui (sacrum, talon, deltoïde…)	≈ 8	★★★
Prévention (retournements, support, macération)	≈ 8	★★★
TVP / EP / complications cardiovasculaires	≈ 7	★★★
Facteurs de risque (incontinence, dénutrition…)	≈ 6	★★
Complications respiratoires / urinaires / digestives	≈ 5	★★
PAON / ostéoporose d'immobilisation / amyotrophie	≈ 4	★★
Traitement de l'escarre (soins locaux, chirurgie)	≈ 4	★★
Complications neurologiques (compressions)	≈ 2	★

Sources : cours Pr Benlebna (Médecine Physique) + Banque QCM OTR

1 · Définition et causes TOMBE EN QCM ×3 ★★

Le mot **décubitus** vient de *décubar* = être couché = position allongée prolongée. L'immobilité est un état anormal associant l'absence quasi complète de mouvement et la perte des contraintes gravitaires.

Définition : toute complication due à un alitement prolongé de cause médicale, chirurgicale ou autre. La gravité va de la superficie à la profondeur. Le traitement est long et peu motivant → **la prévention est la seule option valable**.

Causes principales du décubitus

- Coma / long séjour en réanimation
- Polytraumatisés graves
- Affections neurologiques centrales (paraplégie, tétraplégie, TC, hémiplégie) et périphériques (SGB)
- Affections médicales chroniques, rhumatismes inflammatoires, maladies infectieuses
- Défaillance cardiorespiratoire, néoplasie, vieillissement

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×3
✔ Les complications de décubitus surviennent après une immobilisation prolongée
✔ Elles sont plus fréquentes chez les personnes âgées
✔ Les escarres sont une complication de la paraplégie et de la tétraplégie
✘ Elles touchent exclusivement l'adulte jeune / les enfants

2 · L'escarre — définition, stades, topographie TOMBE EN QCM ×15 ★★★

L'escarre (ulcère de pression) est une lésion cutanée et sous-cutanée provoquée par une **compression prolongée des parties molles sur les reliefs osseux**. C'est la complication cutanée la plus redoutée du décubitus.

Classification internationale (EPUAP / NPIAP) — 4 stades

Stade	Description clinique	Tissus touchés
1	Érythème persistant ne blanchissant pas à la vitropression. Zone parfois douloureuse, plus chaude ou froide.	Peau intacte. **Réversible**.
2	Désépidermisation ou phlyctène (ampoule ouverte/fermée). Ulcération superficielle rosée sans nécrose.	Perte partielle d'épaisseur (épiderme ± derme).
3	Perte totale de substance cutanée. Fibrine (jaune) ou nécrose (noire) possible.	Hypoderme visible. Muscles/os **non** exposés.
4	Perte tissulaire profonde et totale. Exposition muscles, tendons, cartilages ou os.	Risque majeur d'**ostéomyélite**.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×10
✔ Stade 1 = érythème ne s'effaçant pas à la vitropression (réversible)
✔ Stade 2 = désépidermisation / phlyctène (perte partielle d'épaisseur)
✔ Stade 4 = exposition os/muscles → rechercher ostéite si contact osseux
✘ On ne distingue que deux stades (érythème / perte profonde) — **faux**, il y en a 4
✘ Toutes les lésions sont réversibles quel que soit le stade — **faux** (stade 3–4 non)

Topographie — zones d'appui

- **Décubitus dorsal** : sacrum +++ , talons, occiput, omoplates, malléoles externes
- **Décubitus latéral** : trochanter, malléoles, oreille, épaule
- **Position assise** : ischions, sacrum, talons
- **Région deltoïdienne** : rarement siège d'escarres (piège classique QCM)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8
✔ Zone rarement siège d'escarres = région deltoïdienne
✔ Zones classiques = sacrum, talons, malléoles, occiput, trochanter
✔ La localisation correspond aux zones d'appui selon la position du patient

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

3 · Facteurs favorisants et prévention de l'escarre TOMBE EN QCM ×10 ★★★

Facteurs favorisants

- **Extrinsèques (mécaniques)** : pression exagérée ou prolongée, cisaillement, macération
- **Intrinsèques** : troubles de la sensibilité, de la motricité, de la vigilance ; pathologie vasculaire, HTA, diabète
- **Généraux** : âge, dénutrition (IMC < 18,5), déshydratation, hypoxie, fièvre, **incontinence urinaire et anale**

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6

✔ Développer une escarre est favorisé par l'incontinence urinaire ou anale
✔ Facteurs extrinsèques = pression, cisaillement, macération
✔ L'apparition d'escarres nécessite suppression de l'appui + correction des facteurs de risque

Principes de prévention TOMBE EN QCM ×8

1. **Changement de position toutes les 2 à 4 heures** (au minimum) + surveillance systématique des points d'appui
2. Support approprié : matelas à pression alternante, lit à aéro-suspension
3. Prévenir toute macération (surtout incontinence)
4. Apports nutritionnels suffisants
5. Mobilisations passives ou actives quotidiennes
6. Massages des zones à risque (souvent cités en QCM)

CE QUI EST TOMBÉ

✔ Prévention = retournements + support adapté + prévention de la macération
✔ Changements de position réguliers = mesure essentielle
✘ Les massages seuls suffisent / les antibiotiques préventifs / les AINS — **faux**

4 · Traitement de l'escarre constituée et complications TOMBE EN QCM ×6 ★★

1. **Suppression de l'appui** sur la zone + adaptation des facteurs de risque
2. **Soins locaux** : détersion, pansements adaptés. **Pas d'antiseptiques ni d'antibiotiques locaux en routine** sur lésion ouverte
3. **Antibiothérapie systémique** uniquement si escarre infectée (signes généraux ou locaux d'infection)
4. **Chirurgie** (lambeaux cutanés) en cas d'évolution défavorable
5. Si contact osseux au fond d'une escarre stade 4 → **rechercher une ostéite**

Complications de l'escarre

- Ostéite / ostéoarthrite (surtout stade 4)
- Anémie, hypoprotidémie
- Septicémie

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6

✔ Sur lésion ouverte : pas d'antiseptiques / antibiotiques locaux en routine
✔ Contact osseux stade 4 → rechercher ostéite
✔ Traitement d'une escarre infectée ≠ antibiothérapie locale seule
✔ Le principal risque des escarres est l'infection
✘ L'escarre est une complication tardive uniquement — elle peut apparaître rapidement

5 · Complications cardiovasculaires TOMBE EN QCM ×7 ★★★

Ce sont les **plus précoces** (dès le 4^{e} jour d'immobilisation).

- **Thrombose veineuse profonde (TVP)** : favorisée par stase veineuse + absence de contraction musculaire + modifications de viscosité sanguine. Peut être **asymptomatique** et se révéler par une embolie pulmonaire.
- **Embolie pulmonaire (EP)**
- **Déconditionnement cardio-vasculaire** à l'effort (précoce, pas tardif)
- **Hypotension orthostatique** à la verticalisation progressive

Prévention TVP : bas de contention + HBPM (héparine de bas poids moléculaire)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×7

✔ TVP peut être asymptomatique et découverte devant une EP
✔ TVP favorisée par la stase veineuse
✔ Prévention = bas de contention + HBPM
✔ Déconditionnement cardio-vasculaire est **précoce** (pas tardif) — proposition « tardif » = fausse
✔ Verticalisation progressive peut provoquer une hypotension orthostatique

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

6 · Complications respiratoires TOMBE EN QCM ×5 ★★

L'immobilisation augmente la **stase bronchique**, l'encombrement et l'infection.

- Micro-atélectasies (précoces)
- Encombrement bronchique
- **Pneumopathie de décubitus**
- Hypoventilation / syndrome restrictif de décubitus

CE QUI EST TOMBÉ

✔ L'immobilisation augmente la stase, l'encombrement et l'infection
✔ Pneumopathie de décubitus = complication respiratoire classique

7 · Complications de l'appareil locomoteur TOMBE EN QCM ×5 ★★

A. Ostéoporose d'immobilisation

- Hyper-résorption osseuse (trabéculaire + corticale)
- Favorise fractures et lithiase rénale
- Hypercalciurie dès J2, maximale S7–S10
- Radio : déminéralisation visible seulement après ≈ 3 semaines
- Prévention : verticalisation précoce et régulière

B. Raideurs articulaires

Causes : rétractions capsulo-ligamentaires et tendineuses, PAON, algoneurodystrophie, spasticité, nécrose localisée des surfaces articulaires.

C. Paraostéoarthropathie neurogène (PAON) TOMBE EN QCM ×2

Processus d'**ossification ectopique** au contact des grosses articulations → ankylose articulaire. Touche l'os et l'articulation.

D. Complications musculaires

- Rétractions musculaires
- Amyotrophie de non-utilisation (fonte musculaire)
- Perte de la force de contraction maximale

Prévention locomotrice : positionnement correct (orthèses de posture), postures alternées, mobilisations articulaires passives/actives.

CE QUI EST TOMBÉ

✔ PAON touche l'os et l'articulation (ossification ectopique)
✔ Ostéoporose d'immobilisation → risque de fractures et lithiase rénale

8 · Complications neurologiques, digestives et urinaires TOMBE EN QCM ×4 ★★

Neurologiques — compressions des nerfs périphériques

- Nerf ulnaire (gouttière épitrochléo-olécranienne)
- Nerf radial (gouttière humérale)
- Tronc du nerf sciatique (derrière extrémité supérieure du fémur)
- Nerf fibulaire commun (col de la fibula)

Digestives

- Constipation, fécalome, distension abdominale (stase)

Urinaires

- Stase urinaire, infection urinaire, lithiase (liée à l'hypercalciurie)
- Vessie neurologique (dans les contextes neurologiques)
- Prévention des infections urinaires : sondage intermittent préférable au drainage continu

CE QUI EST TOMBÉ

✔ Prévention des infections urinaires = maintien d'un drainage adapté (sondage intermittent souvent préféré)
✔ Vessie neurologique = complication urinaire possible
✔ TVP touche les veines (pas les artères)

9 · Complications psychologiques

Anxiété, dépression, syndrome de glissement chez le sujet âgé, désorientation. À prendre en charge précocement (écoute, mobilisation, environnement stimulant).

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

Fiche express — À retenir pour les QCM

Chronologie des complications

Délai	Complications principales
Immédiat / J1–J4	TVP / EP, micro-atélectasies, début d'escarre si pression non relevée
1er mois	Hypotension orthostatique, amyotrophie, rétractions, ostéoporose (hypercalciurie), infections urinaires/respiratoires
Tardives	PAON, raideurs fixées, séquelles d'escarres (ostéite), complications psychologiques

Stades d'escarre — mémo express

1 = Rougeur qui ne blanchit pas (peau intacte) → réversible
2 = Phlyctène / désépidermisation (épiderme ± derme)
3 = Perte cutanée totale jusqu'à l'hypoderme (pas d'os/muscle exposé)
4 = Os / muscle / tendon exposé → risque d'ostéite

Zones d'appui à connaître par cœur

Dorsal : **sacrum** +++ · talons · occiput · malléoles
Latéral : trochanter · malléoles
Assis : ischions
Rarement : région deltoïdienne

Les pièges classiques des QCM

- ✘ L'escarre est toujours une complication tardive → elle peut apparaître en quelques heures si pression non relevée
- ✘ On ne distingue que 2 stades → il y en a 4 (EPUAP/NPIAP)
- ✘ Toutes les lésions sont réversibles → faux pour stades 3–4
- ✘ Antibiothérapie locale systématique sur escarre ouverte → non
- ✘ Déconditionnement cardio-vasculaire est tardif → il est précoce
- ✘ Zone d'appui fréquente = deltoïde → c'est la zone rare
- ✘ TVP touche les artères → non, les veines

Prévention en une phrase

Changer de position toutes les 2–4 h + support adapté + pas de macération + nutrition + mobilisations + bas de contention/HBPM + verticalisation précoce.

Conclusion du cours : les complications du décubitus sont fréquentes, potentiellement graves et souvent évitables. La prévention (positionnement, supports, nutrition, anticoagulation, kinésithérapie) reste le pilier de la prise en charge. Une escarre constituée impose suppression d'appui, soins locaux adaptés et recherche d'ostéite au stade 4.

Sources : cours Pr F. Benlebna (MPR – CHU Mostaganem) + Banque QCM OTR (≈ 36 questions escarres / complications du décubitus)